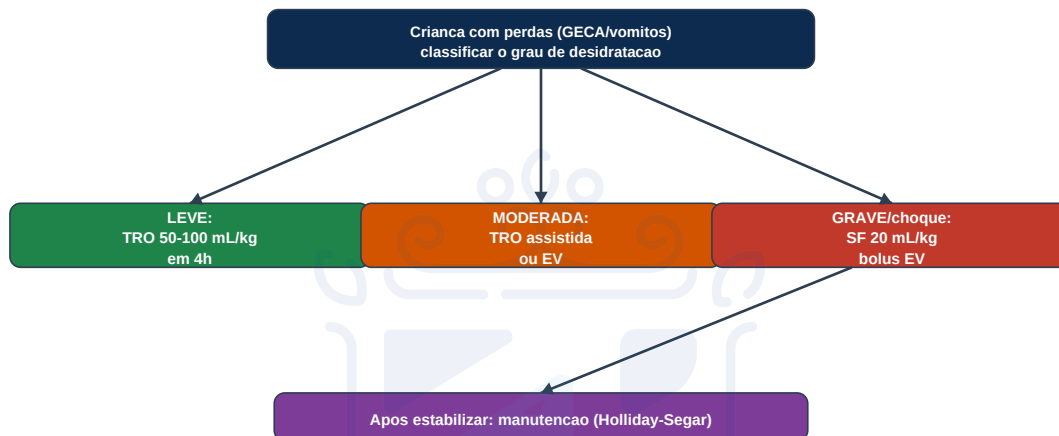


DESIDRATAÇÃO EM PEDIATRIA — TRO x EV

FLUXOGRAMA — GRAU DEFINE A VIA

DESIDRATAÇÃO — CLASSIFICAR E HIDRATAR



DEFINIÇÃO E CAUSAS

O QUE É

- Perda de água e eletrólitos suficiente para causar sinais/sintomas; maior risco em lactentes e crianças pequenas
- Causa mais comum: GASTROENTERITE AGUDA (diarreia/vômitos)
- Outras: febre prolongada, baixa ingestão, sudorese, diuréticos, doenças metabólicas (ex.: CAD)
- A base do tratamento é a REIDRATAÇÃO; a via depende do grau

CLASSIFICAÇÃO DO GRAU DE DESIDRATAÇÃO

Sinal	Leve / sem sinais	Moderada	Grave
Estado geral	Alerta	Irritado/sedento	Letárgico/comatoso
Olhos / mucosas	Normais	Fundos / secas	Muito fundos / muito secas
Turgor / TEC	Normal	Lento	Muito lento (> 3s)
Lágrimas / diurese	Presentes	Reduzidas	Ausentes / oligoanúria

RED FLAGS

SINAIS DE GRAVIDADE / CHOQUE

- Letargia ou irritabilidade extrema; rebaixamento do nível de consciência
- Oligúria/anúria; vômitos incoercíveis; incapacidade de ingerir líquidos
- Taquicardia persistente, hipotensão, sinais de CHOQUE (TEC > 3s, extremidades frias)
- Fontanela muito deprimida (lactente); olhos muito encovados
- Suspeita de sepse ou causa metabólica (CAD) -> internação e manejo específico

AVALIAÇÃO E EXAMES

NO PS

- Anamnese: duração/volume das perdas, ingesta, número de micções, febre, aceitação, nível de consciência, peso prévio
- Exame: estado geral, sinais vitais, turgor, mucosas, olhos, fontanela, enchimento capilar, peso atual
- Desidratação leve: exames geralmente DESNECESSÁRIOS
- Glicemia capilar em lactente/prostração
- Variáveis (mod/grave): eletrólitos, gasometria, ureia/creatinina, urina I, hemograma se infecção

TRATAMENTO

Rx POR GRAU

LEVE/MODERADA: Soro de reidratação ORAL (SRO) 50-100 mL/kg em 4 horas (TRO assistida na moderada)
Ondansetrona 0,15 mg/kg/dose se vômitos (facilita a TRO)
GRAVE/choque: SF 0,9% 20 mL/kg em BOLUS EV (repetir se necessário)
Após estabilizar: manutenção pela regra de Holliday-Segar + repor perdas
MANTER aleitamento materno; jejum apenas se vômitos intensos; retomar dieta precocemente
Reposição após cada evacuação/vômito; NÃO usar refrigerante/suco/chá como reidratação

INTERNAÇÃO x ALTA

DECISÃO

- ☐ INTERNAR: desidratação moderada/grave, falha da TRO, vômitos incoercíveis, rebaixamento, distúrbio eletrolítico, suspeita de sepse, condição social desfavorável
- ☐ ALTA: melhora clínica, boa aceitação oral, diurese presente, sinais vitais estáveis, responsável orientado/confiável
- ☐ Casa: SRO conforme aceitação + dieta habitual/aleitamento + antiemético se necessário
- ☐ Oferecer líquidos em pequena quantidade e com frequência
- ☐ Retorno IMEDIATO: queda da diurese, vômitos persistentes, febre alta, prostração/sonolência, piora geral

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Criança ____ anos/ ____ kg com desidratação ____ (leve/moderada/grave); causa: ____ (GECA?).
- Sinais vitais ____; diurese ____; nível de consciência ____; glicemia ____.
- Condutas: TRO ____ / SF 0,9% 20 mL/kg bolus ____; antiemético ____.
- Solicito hospital com suporte pediátrico (grave/choque/falha da TRO).

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Lactente com gastroenterite, desidratação grave e sinais de choque. Qual a conduta imediata?

- A) Soro de reidratação oral 50 mL/kg
- B) SF 0,9% 20 mL/kg em bolus endovenoso (repetir se necessário)
- C) Apenas observação
- D) Antibiótico endovenoso
- E) Restrição hídrica

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é o tratamento de escolha da desidratação LEVE a moderada na criança?

- A) Hidratação endovenosa de rotina
- B) Soro de reidratação oral (50-100 mL/kg em 4 horas)
- C) Refrigerante e sucos
- D) Jejum absoluto
- E) Antibiótico oral

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual medicação pode facilitar a terapia de reidratação oral na criança com vômitos?

- A) Metoclopramida em dose alta
- B) Ondansetrona 0,15 mg/kg/dose
- C) Dimenidrinato intramuscular
- D) Loperamida
- E) Hioscina

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Sobre a alimentação na criança com gastroenterite e desidratação, é correto:

- A) Suspender o aleitamento materno
- B) Manter o aleitamento materno e retomar a dieta precocemente (jejum só se vômitos intensos)
- C) Jejum absoluto por 48h
- D) Oferecer apenas chás
- E) Dieta rica em açúcares simples

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual orientação aos pais é correta na alta da criança com gastroenterite?

- A) Repor perdas com refrigerante ou suco
- B) Oferecer SRO em pequenas quantidades e com frequência; repor após cada evacuação/vômito
- C) Suspender líquidos para 'descansar' o intestino
- D) Usar antibiótico de rotina
- E) Dar grandes volumes de uma só vez

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Desidratação grave com choque exige reposição venosa imediata: SF 0,9% 20 mL/kg em bolus, repetindo conforme a resposta, antes de passar à manutenção. A TRO não é adequada no choque.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A desidratação leve/moderada é tratada com soro de reidratação oral (50-100 mL/kg em 4h), preferencial por ser eficaz, seguro e fisiológico. EV reserva-se à falha da TRO ou à forma grave.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A ondansetrona (0,15 mg/kg/dose) reduz os vômitos e aumenta o sucesso da terapia de reidratação oral, evitando hidratação venosa desnecessária.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Mantém-se o aleitamento materno e retoma-se a dieta precocemente (jejum apenas se vômitos intensos); a realimentação precoce melhora o desfecho na gastroenterite.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Orienta-se oferecer SRO em pequenas quantidades e com frequência, repondo perdas após cada evacuação/vômito. Refrigerantes, sucos e chás não são adequados (osmolaridade/composição inadequadas).

SM24
Suporte ao Plantão Médico